

Platform Kesehatan Mental untuk Gen Z Indonesia

Dokumen Konsep Produk

Sub-tema: Health | RISTEK Hackathon 2026

Grand Theme: Tech for Good

Architecting Sustainable Solutions for Tomorrow's Challenges

Daftar Isi

1. Definisi Masalah
2. Mengapa Kelompok Ini Dapat Dibantu Teknologi
3. Rancangan Produk
4. Yang Harus Dihindari
5. Diferensiasi dari Produk yang Sudah Ada
6. Model Bisnis
7. Kelayakan Teknis (4 Hari Pengembangan)
8. Antisipasi Pertanyaan Juri
9. Ringkasan

1. Definisi Masalah

Kebanyakan orang mendefinisikan masalah ini terlalu dangkal: “anak muda stres, butuh psikolog.” Definisi tersebut menyesatkan karena mengarahkan solusi ke jalur yang secara struktural buntu. Masalah sebenarnya terdiri dari tiga lapis, dan setiap lapis menuntut pendekatan yang berbeda.

1.1 Lapis 1 — Jumlah psikolog secara matematis mustahil memenuhi kebutuhan

Per Februari 2023, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia mencatat jumlah psikolog klinis di seluruh Indonesia hanya **3.605 orang**. Sementara itu, Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional (I-NAMHS) menunjukkan **1 dari 3 remaja Indonesia usia 11–17 tahun — sekitar 15,5 juta jiwa — mengalami gangguan mental** dalam kurun 2021–2022.

Rasio kasarnya: satu psikolog klinis untuk sekitar 4.300 remaja bermasalah, dan angka itu *belum* memperhitungkan populasi dewasa. Implikasinya tegas: **membangun aplikasi yang sekadar “menghubungkan orang ke psikolog” tidak menyelesaikan masalah apa pun** — psikolognya memang tidak tersedia. Menambah satu marketplace psikolog lagi hanya memperpanjang antrean untuk sumber daya yang jumlahnya tetap.

1.2 Lapis 2 — Biaya menjadi tembok bagi yang paling membutuhkan

Per 2026, tarif satu sesi terapi berkisar **Rp150.000 hingga lebih dari Rp1.000.000**, bergantung pada jenis layanan, lokasi, dan kualifikasi tenaga ahli. Terapi umumnya membutuhkan beberapa sesi, bukan sekali datang. Bagi mahasiswa, ini bukan persoalan “mau atau tidak”, melainkan memang tidak terjangkau.

1.3 Lapis 3 — Jalur gratis terbatas dan menggunakan seleksi

Ini lapis yang paling sering luput dari perhatian. Layanan konseling gratis yang tersedia menerapkan sistem seleksi karena kuotanya terbatas, dan prioritas diberikan kepada mereka yang kondisinya paling mendesak. Terdapat testimoni nyata seorang Gen Z yang berkali-kali mendaftar layanan konseling gratis berbasis chat namun tidak pernah terpilih.

“Pas pendaftaran diminta mengisi data diri, lalu menceritakan perasaan secara singkat. Mungkin yang ditolong yang kondisinya lebih urgent. Namanya orang menunggu kesempatan konseling gratis, pasti banyak.” — testimoni pengguna layanan konseling gratis

Artinya, orang yang “belum cukup parah” justru tersingkir dari antrean — padahal merekalah yang paling mungkin dicegah agar tidak memburuk.

1.4 Kesimpulan: ada celah yang tidak dilayani siapa pun

Dari ketiga lapis di atas muncul satu kelompok besar yang terjebak **di antara “baik-baik saja” dan “cukup parah untuk mendapat prioritas”**. Kelompok ini tidak dilayani oleh sistem mana pun: terlalu berat untuk diabaikan, tetapi tidak cukup mendesak untuk memenangkan kuota layanan gratis, sekaligus tidak mampu membayar layanan berbayar. **Kelompok inilah target produk.**

2. Mengapa Kelompok Ini Dapat Dibantu Teknologi

Data menunjukkan Gen Z memiliki karakteristik yang khas dan relevan secara desain produk. Mereka cenderung berupaya memahami masalahnya sendiri terlebih dahulu sebelum mencari bantuan profesional, dan sudah aktif melakukan self-care mandiri seperti journaling, meditasi, afirmasi, hingga olahraga ringan. Namun sebagian jatuh ke coping yang tidak adaptif: menghindar, penggunaan gawai berlebihan, atau konsumsi berlebihan sebagai pelarian.

Insight kuncinya: **mereka sudah memiliki kebiasaan mencoba mengatasi sendiri**. Yang belum mereka miliki adalah tiga hal berikut.

1. Cara mengetahui apakah kondisi mereka membaik atau memburuk — saat ini tidak ada ukuran objektif, hanya perasaan sesaat.
2. Cara mengetahui kapan harus berhenti mengatasi sendiri dan mulai mencari bantuan profesional.
3. Tempat bercerita ketika kondisinya belum cukup parah untuk memenangkan kuota konseling gratis.

Produk ini menyerang ketiga titik tersebut. **Produk ini tidak menggantikan psikolog** — justru sebaliknya, produk ini mengarahkan pengguna ke psikolog pada saat yang tepat.

3. Rancangan Produk

3.1 Fitur 1 — Journaling dengan Deteksi Pola (inti produk)

Cara kerja

Pengguna menulis bebas layaknya diary: tanpa format kaku, tanpa kuesioner yang membosankan, sepanjang atau sependek apa pun, kapan saja.

Peran AI dan batasannya

AI **tidak menjawab, tidak menasihati, dan tidak berkomentar**. Tugasnya hanya satu: menganalisis tulisan yang terkumpul lintas waktu dan menyajikan polanya kembali kepada pengguna. Contoh keluaran:

“Dari 12 entri bulan ini, kata bernada negatif paling sering muncul pada hari Senin dan Kamis. Tiga dari empat entri dengan mood terendah menyebutkan kurang tidur. Dibanding bulan lalu, entri bernada positif naik dari 30% ke 45%.”

Mengapa ini berharga, bukan gimmick

Manusia sangat buruk dalam menilai tren emosinya sendiri. Ketika sedang buruk, semuanya terasa “selalu buruk”. Data objektif dari tulisan sendiri memberikan cermin yang tidak dapat disediakan oleh

ingatan. Ini juga persis jenis pekerjaan yang AI genuinely lebih unggul dibanding manusia: menemukan pola dari sejumlah besar data teks.

Mengapa ini aman

Keluarannya bersifat deskriptif tentang tulisan pengguna sendiri, bukan diagnosis maupun nasihat. Tidak ada risiko “AI salah menyarankan sesuatu pada momen krisis”, karena AI tidak menyarankan apa pun.

3.2 Fitur 2 — Skrining Terstandar Berkala

Cara kerja

Secara berkala (misalnya tiap dua minggu), pengguna mengisi **PHQ-9** (gejala depresi) dan **GAD-7** (kecemasan) — instrumen yang telah tervalidasi secara klinis dan digunakan luas secara internasional, bukan kuis buatan sendiri.

Keluaran dan tiga jalur tindak lanjut

Level Skor	Tindak Lanjut
Rendah	Diarahkan ke self-help tools (Fitur 1 dan 3); pemantauan berkelanjutan.
Sedang	Rekomendasi konseling, disertai informasi konkret jalur BPJS — banyak Gen Z belum tahu layanan psikologi dapat ditanggung BPJS lewat rujukan.
Tinggi / indikasi krisis	Langsung menampilkan jalur bantuan profesional dan hotline; melewati (bypass) seluruh fitur lain.

Mengapa ini penting untuk kredibilitas

Penggunaan instrumen baku (bukan kuesioner buatan sendiri) memberi produk dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjawab pertanyaan mendasar: atas dasar apa sistem menyimpulkan seseorang perlu bantuan?

3.3 Fitur 3 — Peer Support Termoderasi AI

Fitur ini paling ambisius sekaligus paling berisiko. **Jelaskan dengan sangat hati-hati, atau tidak sama sekali.**

Cara kerja

Karena jumlah psikolog tidak akan pernah cukup, orang dengan pengalaman serupa saling mendukung — bukan memberi terapi, melainkan memberi pengalaman “saya tidak sendirian” yang justru kerap menjadi kebutuhan utama. AI berperan pada dua titik:

- **Matching** — mencocokkan pengguna dengan orang lain yang konteksnya serupa (misalnya sama-sama sedang skripsi, sama-sama menghadapi kesulitan finansial).

- **Safety monitoring** — memantau percakapan untuk mendeteksi tanda krisis (ideasi bunuh diri, self-harm). Begitu terdeteksi, sistem langsung melakukan eskalasi: menampilkan hotline, menginformasikan jalur profesional, dan menghentikan alur peer support untuk kasus tersebut.

Kritik jujur atas fitur ini

Peer support tanpa moderasi ketat dapat berbahaya: dua orang yang sedang buruk bisa saling memperburuk (co-rumination), atau ada yang memberi “saran” yang keliru. Jika fitur ini diambil, safety layer bukan pelengkap melainkan syarat mutlak — dan harus ditonjolkan saat pitching, bukan disembunyikan.

4. Yang Harus Dihindari

JANGAN membuat AI chatbot yang berperan sebagai konselor atau teman curhat yang membalas. Ini godaan terbesar karena paling mudah dibangun (cukup memanggil API LLM) dan tampak paling “canggih” saat demo. Alasannya untuk dihindari:

- LLM dapat merespons keliru tepat pada momen paling kritis — dan taruhannya nyawa, bukan sekadar nilai kompetisi.
- Pengguna dapat membentuk ketergantungan emosional pada chatbot, yang justru menjauhkan mereka dari bantuan manusia nyata — kebalikan dari tujuan produk.
- Juri yang memahami isu ini akan menyerang titik tersebut lebih dulu, dan tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan.

Posisi yang defensibel: AI dalam produk ini bekerja pada **data**, bukan pada **percakapan dengan orang yang sedang rapuh**. Analisis pola dari tulisan (aman) dan deteksi krisis untuk eskalasi (aman dan berguna) — bukan menjadi lawan bicara.

5. Diferensiasi dari Produk yang Sudah Ada

Aplikasi kesehatan mental di Indonesia (Riliv, KALM, fitur psikolog di Halodoc, dan sejenisnya) mayoritas berbentuk marketplace psikolog berbayar: menghubungkan pengguna ke psikolog dan mengambil komisi. Konsekuensinya:

- Tetap terbentur tembok yang sama — jumlah psikolog terbatas dan biaya mahal.
- Mereka yang tidak mampu membayar tetap tidak terlayani, padahal itulah segmen terbesar dari masalah.

Produk ini **secara sengaja tidak berkompetisi di ruang tersebut**. Positioning-nya: melayani orang *sebelum dan di antara* sesi profesional, termasuk mereka yang belum atau tidak dapat mengakses

psikolog sama sekali. Ketika pengguna akhirnya memang membutuhkan psikolog, produk ini justru mengarahkan ke sana — termasuk melalui jalur BPJS yang gratis — bukan bersaing.

Analoginya: produk yang ada sekarang adalah “toko obat”. Produk ini adalah “alat ukur beserta panduan kapan harus ke dokter”.

6. Model Bisnis

Jalur paling realistis sekaligus paling etis: **B2B ke institusi**.

Kampus

Layanan kesejahteraan mahasiswa. Kampus memiliki insentif nyata karena masalah kesehatan mental mahasiswa berdampak langsung pada tingkat kelulusan dan angka putus studi, dan kampus memiliki anggaran kemahasiswaan. Produk menyediakan dashboard agregat-anonim (persentase mahasiswa dalam kategori risiko, tren per periode) tanpa membuka identitas individu.

Perusahaan

Program kesejahteraan karyawan (employee wellbeing) — pasar yang sedang bertumbuh dan memiliki anggaran tersendiri.

Mengapa bukan B2C langsung

Menagih pembayaran dari orang yang sedang mengalami kesulitan mental sekaligus finansial bermasalah secara etis, dan sekaligus lemah secara bisnis — segmen ini justru yang paling tidak mampu membayar. Model B2B membuat produk gratis bagi pengguna akhir, yang justru memperkuat pesan “Tech for Good”.

7. Kelayakan Teknis (4 Hari Pengembangan)

Komponen	Kompleksitas	Catatan
Journaling dan penyimpanan	Rendah	CRUD standar.
Analisis pola teks	Sedang	Sentiment analysis dan ekstraksi kata kunci; gunakan model/API yang tersedia, tidak perlu training sendiri.
Visualisasi tren mood	Rendah	Charting library standar.
Skrining PHQ-9 / GAD-7	Sangat rendah	Kuesioner dan skoring rule-based; rumus sudah baku.

Komponen	Kompleksitas	Catatan
Deteksi krisis	Sedang	Kombinasi keyword-based (deterministik) dan klasifikasi. Jangan mengandalkan AI semata untuk hal sekritis ini.
Peer support dan matching	Tinggi	Paling berat. Pertimbangkan sebagai roadmap, bukan MVP.

Rekomendasi cakupan MVP

Fitur 1 + Fitur 2 + safety layer. Fitur 3 (peer support) masuk roadmap dan dijelaskan dalam proposal sebagai fase berikutnya. Cakupan ini realistis untuk empat hari, dan **Fitur 1 dan 2 saja sudah merupakan produk yang utuh dan bermakna** — bukan produk setengah jadi.

8. Antisipasi Pertanyaan Juri

Kemungkinan Pertanyaan	Jawaban yang Defensible
“Apa bedanya dengan Riliv atau KALM?”	Mereka marketplace psikolog berbayar. Produk ini melayani segmen yang tidak terjangkau model tersebut, dan justru merujuk pengguna ke profesional.
“Kalau ada pengguna yang bunuh diri, tanggung jawab siapa?”	Safety layer eksplisit: deteksi krisis memicu eskalasi ke hotline dan jalur profesional. Produk tidak pernah memposisikan diri sebagai pengganti terapi.
“Apakah AI-nya bukan sekadar tempelan?”	AI mengerjakan hal yang manusia genuinely tidak bisa: menemukan pola dari puluhan entri teks lintas waktu — bukan chatbot yang membalas.
“Data curhat itu sensitif, bagaimana privasinya?”	Enkripsi data, tidak dibagikan ke institusi dalam bentuk identifiable, dan dashboard institusi hanya berupa agregat-anonim.

Pertanyaan privasi adalah yang paling sering luput dipersiapkan, padahal untuk produk yang isinya catatan pribadi pengguna, pertanyaan itu hampir pasti muncul. Siapkan jawabannya sejak awal, bukan dadakan saat sesi Q&A.

9. Ringkasan

Masalahnya bukan sekadar “anak muda stres”, melainkan **ketimpangan struktural antara jumlah orang yang membutuhkan dukungan psikologis dan kapasitas layanan yang tersedia**, dengan lapisan tambahan berupa biaya tinggi dan kuota layanan gratis yang menyeleksi berdasarkan tingkat keparahan. Akibatnya, terbentuk kelompok besar yang tidak dilayani siapa pun.

Solusinya bukan menambah satu lagi marketplace psikolog, melainkan membangun alat yang memberi pengguna **ukuran objektif atas kondisi dirinya sendiri** (analisis pola journaling dan skrining terstandar), lalu **mengarahkan ke jalur bantuan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya** — termasuk jalur gratis lewat BPJS yang selama ini kurang diketahui. AI berperan pada analisis data dan deteksi krisis, bukan sebagai lawan bicara bagi orang yang sedang rapuh.

Model bisnis B2B ke kampus dan perusahaan membuat produk tetap gratis bagi pengguna akhir, sehingga keberlanjutan bisnis dan misi sosial berjalan searah, bukan saling bertentangan.